



**RAPPORT DE L'ATELIER DE CAPITALISATION ET DE PLANIFICATION
DE LA PECMAM APPUYEE PAR LE PAM DANS LE SUD
(Régions Anosy, Androy, Atsimo Andrefana)**



Hôtel Tombotsoa, Fianarantsoa

07 au 09 décembre 2021

I- INTRODUCTION

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition aiguë qui sévit dans le Grand Sud de Madagascar, des conventions ont été signées entre les acteurs de mise en œuvre et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition aiguë modérée, dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana.

Après quelques années d'intervention sur la prise en charge des enfants atteints de la MAM, des ateliers de capitalisation ont été faits mais lors de la mise en œuvre et le suivi au niveau régional on a encore constaté des problèmes au niveau des ACN, de la collaboration avec les CSB, l'implication des bénéficiaires et les autorités locales.

D'où la nécessité de la coordination de toutes ces pratiques mises en commun pour ne pas marquer la différence mais constituer la base d'une mise en œuvre forte et uniformisée du programme national de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, en lien avec le protocole national révisé.

A cet effet, un atelier de capitalisation des acquis a eu lieu à Fianarantsoa du 07 au 09 décembre 2021, intégrant la visite-échanges d'expériences avec d'autres régions, la validation finale des FLA et PTA 2022 ainsi qu'un renforcement de capacité des partenaires afin de mieux répondre aux besoins et d'en tirer des leçons pour améliorer l'efficacité, le partenariat et la qualité des futurs projets.

L'atelier a pour objectifs de :

- Effectuer une visite – échanges d'expérience entre les acteurs PECMAM du grand Sud et de la Région Haute Matsiatra qui met en œuvre les activités PECMAM dans le cadre du Projet PARN, financé par la Banque Mondiale
- Capitaliser et valoriser les expériences des ORN et des partenaires ONG sur la PECMAM afin d'améliorer la qualité des interventions et de la performance pour les prochaines années
- Améliorer la collecte et circuit de rapportage ainsi que l'analyse et la gestion des données
- Mettre à jour la cartographie des interventions PECMAM
- Finaliser et valider les PTA 2022 de chaque ORN à travers l'appui et collaboration avec le PAM
- Renforcer la capacité des partenaires et des staffs du PAM

Outre les participants venant des partenaires du PAM, à savoir ONN, ORN, ONG Fihamy, et ACF il est à noter que cet atelier a vu la participation de l'équipe de l'UNICEF.

II- DEROULEMENT DE L'ATELIER

Jour 1 : 07 décembre 2021

- Discours d'ouverture :

Comme l'atelier a eu lieu parallèlement à la revue des activités d'appui nutritionnel des personnes malades de tuberculose et du VIH/SIDA, une seule cérémonie d'ouverture a été effectuée pour les deux ateliers. La série de discours a été organisée comme suit :

- Coordonnateur Régional / ORN Haute Matsiatra pour souhaiter la bienvenue

- Responsable Urgence / PAM pour remercier les participants
 - Responsable TB / Ministère de la Santé Publique pour relater la liaison entre la prise en charge MAM et l'appui nutritionnel des personnes atteintes de la tuberculose et du VIH/SIDA
 - Chef de Service Suivi-Evaluation / ONN pour l'ouverture officielle
- Présentation des objectifs, agenda, attentes, normes

1- Visite de sites :

Quatre sites ont été retenus pour la visite échange dont les sites de Rova, Igaga, Ambalapaiso et Tsimanarirazana. Le but de la visite n'est pas de comparer les sites PARN avec les sites PECMAM dans le Sud du point de vue couverture, logistique, outils de gestion et intrants, mais plutôt de capitaliser les bonnes pratiques afin d'améliorer les futures interventions.

Les aspects considérés au niveau des sites lors de la visite sont planification, organisation, couverture, logistique, intrants OG contraintes/problèmes rencontrés. Les 4 équipes ont pu relater :

Constats

- PECMAM : très peu de cas par rapport au nombre de cas dans le Sud ;
- PCIMEC : une des activités principale et courante dans les sites PARN ;

Contraintes/problèmes rencontrés : Retard de paiement des indemnités des intervenants.

Bonnes pratiques :

- Traçabilité de lot de Plumpy sup sur tout le circuit dès l'approvisionnement jusqu'au niveau des bénéficiaires ;
- Utilisation du logiciel commcarehq pour la gestion des données ;
- Evaluation mensuelle, au niveau CSB des animateurs pour pouvoir les payer.
- Regroupement mensuel des AC et animateurs (indemnité 6000 Ar) avec la participation de CSB et RDP.

2- Présentation des recommandations de l'atelier de capitalisation 2020 par l'ONN

Les recommandations ont été suivies à plus de 85 %. Les détails sont présentés en annexes.

Jour 2 : 08 décembre 2021

1- Résumé des sessions J1

2- Présentation des résultats de l'enquête SMART effectuée en Octobre-Novembre 2021 dans les 10 Districts du Sud

- Qualité des données, selon ENA for smart : excellent sauf pour le District de Tsihombe qui est acceptable
- Prévalences moyenne sur les 10 districts: MAG 7.6% dont MAM 6.1% et MAS 1.5%

- Par rapport à l'année 2020, une légère amélioration a été constatée. En effet, on a eu la même prévalence de la MAG 7.6% mais avec 5.6% de MAM et 2.0% de MAS.

3- Présentation des résultats préliminaires de l'analyse IPC-MNA effectuée en Décembre 2021

La présentation des résultats a été précédée d'un rappel sur ce qu'est l'IPC : une classification mondiale de l'insécurité alimentaire aiguë, de l'insécurité alimentaire chronique et de la **malnutrition aiguë**.

L'analyse a été réalisée par des analystes et basée sur les données des enquêtes nutritionnelles SMART selon le poids/tailles et le périmètre brachial collectée à l'échelle sur les 10 districts du Sud ainsi que des tendances des maladies produites par le système national d'information sanitaire (DHIS2), des évolutions des admissions MAS, des évolutions des résultats du dépistage PB.

Pour la période courante allant de Octobre à Décembre 2021, tous les 10 Districts sont classés en phase 2 (Alerte) avec un niveau de preuves élevé. Pour la période projetée 1, de Janvier à Avril 2022, les Districts de Taolagnaro, Betroka et Toliara II restent dans la même phase tandis que les 7 autres vont basculer dans la phase 3 (crise). Et pour la 2ème période projetée, c'est-à-dire de Mai à Septembre 2022, tous les Districts vont revenir à la phase 2 sauf Amboasary qui reste dans la phase 3.

4- Présentation des réalisations 2021

Séries de présentation des 3 ORN Anosy, Androy et Atsimo Andrefana et de l'ONG FIHAMY basées sur les analyses FFOM précédées des rapports d'activités.

- ORN AA
 - Effets pervers de la riposte : le fait d'être enceinte est vraiment une opportunité pour recevoir l'appui en vivres ;
 - L'envoi des rapports aux entités gouvernementales est une redevabilité des partenaires coopérants ;
- ORN ANOSY
 - Le problème d'insécurité de la zone nord est un événement d'actualité en voie de recrudescence limitant les interventions de riposte.
 - Le problème de référence et contre référence peut être résolu par l'utilisation de carnet de santé.
- ORN ANDROY
 - Problème de waybill en anglais qui pose un problème aux ACN
 - Proposition d'opérationnalisation de PECMAM mobile dans les zones éloignées car le mandat de l'équipe mobile ACF qu'il ne peut pas intervenir tant que le nombre des enfants MAS est supérieur à 3.
 - Un guide unique pour l'équipe mobile est en cours de validation.

- FIHAMY
 - Problème de doublon : proposition de solution en adoptant la digitalisation.
 - PREVMA : pas de connaissance de l'activité et l'objectif au niveau de la communauté

5- Discussions sur les sous clusters nutrition de district : besoins d'appui pour les ORNs

- Budgétiser les réunions trimestrielles du sous cluster de nutrition de district et semestrielles pour le cluster régional pour l'année 2022
- Suggestions d'organiser les formations des leads de sous-cluster en présentiel au lieu de virtuel pour un meilleur résultat
- Des organismes mettent en œuvre des activités ponctuelles sans tenir au courant le cluster sur place.
- Changement fréquent des représentants des entités pendant les réunions des sous-clusters
- Problème de communication entre le cluster national et régional.

6- Présentation/discussion sur les aspects de SBCC

- Mise en place de « Vondron'ny Mpihaino » au niveau communautaire
- Les messages sont diffusés en dialecte local pour une meilleure « pénétration » et compréhension par les groupes cibles au niveau communautaire.
- Communication en marge de la vente illicite des intrants et vivres : il faut beaucoup d'attention sur la dénonciation car ce sont les autorités locales même qui couvrent les infractions et les prévenus.
- Il faut procéder maintenant aux répressions car c'est un réseau fortement ancré et opérationnel dans le district depuis des années.
- S'adresser à la bonne personne pour les cas de vente illicite (district...)
- Diversification de support et canaux de communication

Contraintes	Proposition de solutions
Coutume	Etudes préalable pour pouvoir adapter la stratégie
Indisponibilité des bénéficiaires lors du jours de PEC	Radio carte et mise en place de groupe d'écoute
Capacité des ACN en termes de communication	Recyclage des ACN
Vente illicite des produits nutritionnels	Sensibilisation auprès des consommateurs (communauté) des ASPE hors cible
Indisponibilité des produits (diversification alimentaire) et message non adapté à la situation sur terrain	Bien définir le message clé et le moyen pour le moyen de communication à adopter
Harmonisation de message clé en temps de crise alimentaire	Bien définir le message clé et le moyen pour le moyen de communication à adopter
Renforcement de la sensibilisation	Utilisation de sonorisation mobile pour la mobilisation durant la distribution. Utilisation de maison de communication à Ambovombe

Perspective 2022

- Existe-t-il de données sur l'activité de communication ? Sensibilisation oui.
- Comment on peut définir les indicateurs qualitatif et quantitatif sur le changement de comportement.
- Proposition d'utilisation des nouvelles technologies IT par téléphone et facebook.
- Campagne intensive
- Multiplication des affiches : écriture et image
- Redynamisation de la plateforme de communication au niveau central pour l'harmonisation de la communication.
- Constitution d'un Groupe de lanceur d'alerte sur facebook.

Jour 3 : 09 décembre 2021

- 1- Exposé sur l'éthique et les valeurs du PAM en vidéo conférence par Risk and compliance officer.
- 2- Continuum de soins : de la prévention en passant par la prise en charge et le suivi.

Les problèmes rencontrés autour du continuum de soin ;

- a. Lutte contre les doublons :
 - i. Mobiliser tous les animateurs si l'on procède à une distribution planifiée au même jour pour des sites de la même commune,
 - ii. Bracelet avec des couleurs pour chaque PDF, utilisation de carnet de santé.
 - iii. Fiche individuelle plus photos de l'enfant et de la mère ;
 - iv. Encre indélébile
 - v. Reconnaissance faciale.
- b. Refus des enfants Mas au niveau CSB à cause de :
 - ✓ Insuffisance de quota,
 - ✓ Pas de communication de DRS au niveau de CSB pour la prise en charge
- c. Problème sur la PEC des enfants guéris MAS au niveau des sites CRENAM à cause de l'absence du numéro MAS. L'équipe mobile qui prend en charge les enfants MAS doit confectionner de cachet pour éviter la falsification par les bénéficiaires.

3- Présentation sur la logistique : domaines d'activités

- a. Appui opérationnel sur les activités humanitaires
- b. Assurer la chaîne d'approvisionnement des Partenaires en vivres
- c. Achat de vivres acheminement et entreposage vers le Magasin principal du PAM (sûreté et qualité de vivres)
- d. Toujours organiser des réunions de travail avec les transporteurs pour lever les incompréhensions.
- e. En cas d'urgence appeler les numéros verts : 034 57 440 04 ; 034 57 133 80

- f. Pour le problème de nombre de sachets dans le carton il faut savoir que le conditionnement est robotisé se basant sur le poids que sur le nombre, donc il vaut mieux compter seulement les cartons suspects.
- g. Mettre en place le lien entre le PD, le LESS et COMET
- h. A propos de waybill ; les mots clés pour les AC sont uniquement « GOOD » et « DAMAGED », ces deux mots aident les AC à réceptionner les vivres avant de signer.
- i. La traduction en malagasy du waybill est en cours d'étude
- j. Utilisation de scotch personnalisé PAM est à envisager
- k. Coté transporteur ; élaborer un protocole d'accord pour protéger tous les acteurs en matière de transport et livraison (AC et transporteurs)
- l. Demande de balance appropriée pour le pesage des cartons.
- m. Mise en place de suivi post livraison.

4- Formation sur l'urgence nutritionnelle par le Responsable Urgence Nutritionnelle / PAM

Les lignes directrices en matière d'urgence nutritionnelle :

- Coordination (ONN, UNICEF)
- Information et exploitations des données
- PECMA
- Carences en micronutriments
- Nutrition de la Mère, du Nourrisson et du Jeune Enfant (NMNJE anciennement ANJE)
- La redevabilité est une prescription envers des donateurs et les entités gouvernementales (prise de décision).

5- Synthèses des recommandations

1) COORDINATION

- Budgétisation du déplacement de l'équipe régionale à une réunion sous cluster au niveau du district
- Appui du sous cluster régional par le cluster national (PV, échanges d'information etc..)
- Analyse des données IPC et SMART pour dégager des plans d'actions lors d'une réunion cluster
- Notification des représentants à une réunion cluster régional par chaque entité
- Pouvoir de décision du cluster

2) SUIVI-EVALUATION

- Implication de l'équipe du gouvernorat et celle du district d'Ampanihy dans le comité technique de l'enquête SMART
- Communication à temps de l'information sur la tenue d'une enquête SMART
- Insertion dans le PTA de l'ORN la supervision des dépistages par l'équipe de l'ORN et des partenaires en vue d'améliorer la qualité des données SSN
- Mise à jour des outils de gestion sur la santé communautaire.
- Demande de power bank pour les tablettes

3) SITE

- Dotation d'un local pour site de nutrition communautaire par la communauté
- Utilisation d'un cahier de visiteur par site

4) INTRANTS/LOGISTIQUE

- Application de la méthode FEFO (First Expired First Out) dans la gestion des intrants ;
- Organisation d'une réunion de travail entre PAM Logistique Amboasary, ORN Anosy et le transporteur pour une mise au point ;
- Reconditionnement des plumpy au départ du magasin de stockage du PAM et utilisation d'un scotch spécial PAM ;
- Pré positionnement des intrants au niveau d'un magasin mère pour éviter la rupture de stock ;
- Réhabilitation des magasins de stockage suivant les normes ;
- Dotation des balances aux sites pour le contrôle du poids des cartons de PS livrés par le transporteur ;
- Vérification du poids des cartons déjà ouverts au moment de la livraison et/ou comptage des sachets dans les cartons en présence du comité ;
- Traduction du « waybill » en malagasy.

5) REFERENCEMENT /CONTRE REFERENCEMENT

- Recensement des enfants moins de 5 ans par les AC respectifs et estimation du nombre d'enfants en charge par site pour comparaison et analyse ;
- Récapitulation par le chef CSB du nombre d'enfants vérifiés et référés aux sites CRENAM pour le suivi du nombre d'enfants en charge au niveau des sites CRENAM ;
- Appui des chefs fokontany au recensement de la population ;
- Estimation des besoins en carnets de santé infantile à envoyer à l'OMS et l'UNICEF ;
- Utilisation des Fiches de référence/contre référence par les CSB ;
- Exigence d'un numéro MAS pour chaque enfant sorti guéri CRENAS pour qu'il puisse continuer son traitement au CRENAM ;
- Codification des enfants MAM.

6) PECMAM/EQUIPE MOBILE

- Mise en place d'équipe mobile PECMAM pour soutenir les sites fixes ;
- Partage mensuel de la liste des fokontany d'intervention de l'ACF à l'ORN pour éviter les doublons et l'augmentation du nombre d'enfants MAM dans un même fokontany et utilisation de cachet par leurs équipes mobiles en cas de référencement vers les sites CRENAM ;
- Dotation de bracelet à chaque enfant prise en charge pour son identification : différente couleur pour chaque site.

7) PCIME

- Voir la possibilité de mise en œuvre de la PCIMEC dans les Fokontany éloignés du CSB
- Cartographie
- Formation des AC sur le protocole.

8/ PLUMPY DOZ

- Renforcement de la sensibilisation avant la distribution et au moment des dépistages ;
- Donner les plumpy doz seulement aux enfants dans les bandes vertes ;
- Renforcement de capacités des AC.

7) COMMUNICATION

- Motivation des ACN pour chaque activité de communication (DC, VAD, EN) ;
- Edition et multiplication des affiches avec beaucoup d'images ;
- Renforcement des sonorisations mobile ;
- Renforcement de la mobilisation de la communauté par des personnes influentes (instituteurs, mères leaders ...) ;
- Mis à jour des messages clés pendant la crise alimentaire (communication de crise) ;
- Formation en cascade des intervenants (ACN et animateurs) sur la CCC et sur l'animation de groupe d'écoute ;
- Production des animations adaptées : marionnette...

- Utilisation de nouvelle technologie (smartphone...)

8/ GESTION DES PLAINTES

- Recueil et partage des informations (les types de plaintes reçues et le nombre de plaintes traitées)
- Mise en place de boîte de doléances par le comité de gestion des plaintes

ANNEXE 1 : Liste des participants